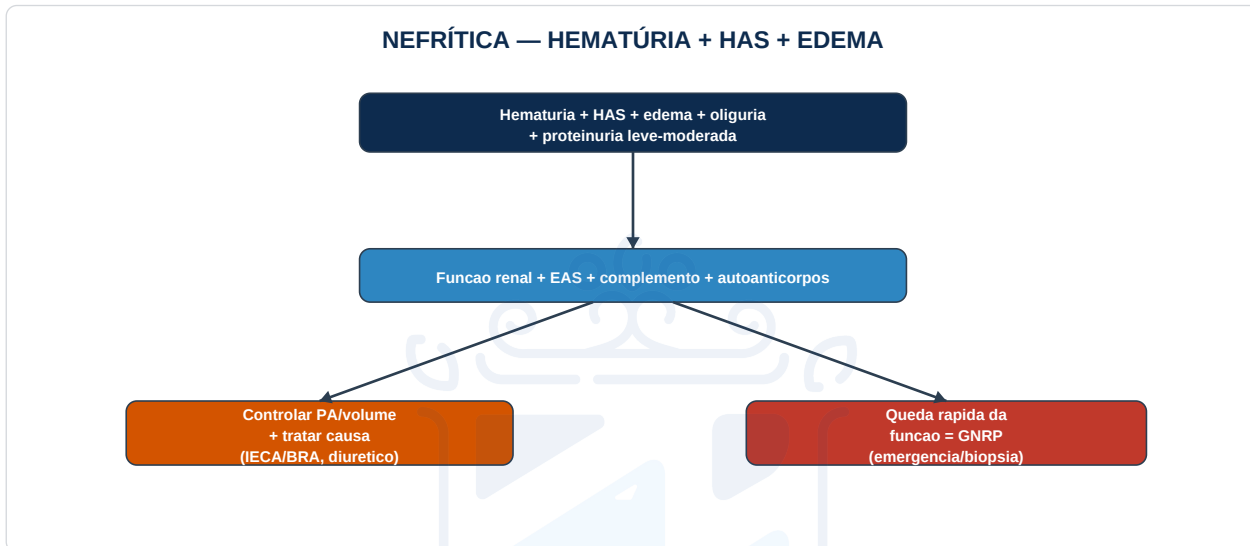


SÍNDROME NEFRÍTICA — INFLAMAÇÃO GLOMERULAR

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Glomerulopatia marcada pela INFLAMAÇÃO glomerular
- Cursa com hematúria, proteinúria, redução da TFG e hipertensão
- Causas principais: pós-infecciosa (estreptococo), GNRP, doenças autoimunes (lúpus, vasculites), nefropatia por IgA
- Diferente da nefrótica (que é por lesão da barreira de filtração, com proteinúria maciça)

QUADRO CLÍNICO

APRESENTAÇÃO

- Hematúria: urina cor de 'coca-cola' ou 'água de carne' (dismórfica, cilindros hemáticos)
- Proteinúria leve a moderada (subnefrótica)
- Oligúria e hipertensão arterial
- Edema geralmente DISCRETO, com predomínio em face e pálpebras pela MANHÃ
- Pós-estreptocócica: 1-3 semanas após faringite/piodermite, com C3 baixo

EXAMES — ESSENCIAIS x ETIOLÓGICOS

Essenciais	Etiológicos (variáveis)
Hemograma, função renal, eletrólitos	Sorologia para estreptococo (ASLO) e hepatites
Gasometria	Autoanticorpos: FAN, anti-DNA, ANCA
Sumário de urina (hematúria dismórfica)	Complemento C3 e C4 (C3 baixo na pós-infecciosa/lúpus)
Proteinúria (isolada ou 24h), creatinina urinária	Biópsia renal se dúvidacurso atípico/perda de função

RED FLAGS — QUANDO PENSAR EM GNRP

PERDA ACELERADA DE FUNÇÃO

- Queda rápida da TFG (dias-semanas) = suspeitar de glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) — emergência
- Cilindros hemáticos + creatinina em ascensão acelerada
- Sinais sistêmicos de vasculite (hemoptise, púrpura, artrite) -> síndrome pulmão-rim
- Hipertensão grave/emergência hipertensiva, sobrecarga volêmica (EAP), hipercalemia
- Esses casos exigem internação, biópsia precoce e avaliação nefrológica urgente

TRATAMENTO NO PS

Rx CONTROLE + CAUSA + COMPLICAÇÕES

Controle pressórico e do volume: anti-hipertensivos (IECA/BRA) + diuréticos para edema/sobrecarga

Tratar a causa: antibiótico se glomerulonefrite pós-infecciosa/bacteriana ativa

imunossupressores (corticoide ± ciclofosfamida) nas autoimunes/vasculites — com nefrologia

Manejo das complicações: corrigir distúrbios hidroeletrólíticos; tratar IRA

Dieta: restrição moderada de sódio; ajustar proteína; controlar K e fósforo se disfunção renal

Acompanhamento com nefrologia

ALTA E PRESCRIÇÃO PARA CASA

ALTA SE

- ☐ Estabilidade hemodinâmica e volemia ajustada
- ☐ Causa subjacente identificada e em tratamento
- ☐ Sem sinais de GNRP / perda acelerada de função / complicação grave
- ☐ Casa: diurético + IECA/BRA (se tolerar) + tratamento específico da causa
- ☐ Acompanhamento precoce com nefrologia garantido

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Síndrome nefrítica: hematúria + HAS + edema + oligúria; proteinúria subnefrótica.
- Creatinina ____ (prévia ____); C3/C4 ____; autoanticorpos ____; contexto infeccioso: ____.
- Conduta: controle pressórico/volume + tratamento da causa.
- Sinais de GNRP? Se sim, solicito internação/biópsia e avaliação nefrológica URGENTE.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança com urina cor de coca-cola, edema palpebral matinal, hipertensão e história de faringite há 2 semanas. Diagnóstico provável?

- A) Síndrome nefrótica
- B) Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (síndrome nefrítica)
- C) Infecção urinária
- D) Litíase renal
- E) Necrose tubular aguda

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado urinário é característico da síndrome nefrítica?

- A) Proteinúria maciça (> 3,5 g/dia) isolada
- B) Hematúria dismórfica com cilindros hemáticos e proteinúria subnefrótica
- C) Glicosúria
- D) Cilindros graxos
- E) Urina límpida sem alterações

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual exame ajuda na etiologia da síndrome nefrítica (baixo na pós-infecciosa e no lúpus)?

- A) Ácido úrico
- B) Complemento (C3 e C4)
- C) TSH
- D) Amilase
- E) CPK

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com síndrome nefrítica e creatinina subindo rapidamente em dias. O que essa evolução sugere?

- A) Resolução espontânea
- B) Glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) — emergência, indicar internação e biópsia
- C) Síndrome nefrótica pura
- D) Cistite
- E) Desidratação simples

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual o objetivo do tratamento no PS da síndrome nefrítica?

- A) Apenas analgesia
- B) Controle da pressão/volume, tratamento da causa e manejo das complicações
- C) Diálise de rotina em todos
- D) Antibiótico para todos os casos
- E) Restrição hídrica absoluta isolada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hematuria macroscópica (coca-cola), edema palpebral matinal e HAS 1-3 semanas após faringite caracterizam a glomerulonefrite pós-estreptocócica, forma clássica de síndrome nefrítica (com C3 consumido).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A síndrome nefrítica cursa com hematuria dismórfica (origem glomerular), cilindros hemáticos e proteinúria subnefrótica. Proteinúria maciça com cilindros graxos é da síndrome nefrótica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A dosagem de complemento (C3/C4) auxilia a etiologia: o C3 está baixo na glomerulonefrite pós-infecciosa e na nefrite lúpica, orientando a investigação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Síndrome nefrítica com queda acelerada da função renal (dias-semanas) sugere GNR — emergência nefrológica que requer internação, biópsia precoce e considerar pulsoterapia.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No PS, trata-se a síndrome nefrítica controlando pressão e volume (IECA/BRA, diuréticos), tratando a causa subjacente e manejando complicações (distúrbios hidroeletrólíticos, IRA).

SM24
Suporte ao Plantão Médico